第115回看護師国家試験（2026年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録15問（直接眼科3・関連領域5・弱い関連7）。実施日：令和8年2月15日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第115回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

問題一覧

問題ID	区分	分類	テーマ	公式正答
115A03	必修	弱い関連	レム睡眠（眼球運動）	2
115A20	必修	弱い関連	接触感染予防策（ゴーグル）	2
115A25	必修	直接眼科	対光反射に関与する神経	1
115A47	一般	関連領域	職業と健康障害（緑内障・眼疲労）	2
115A88	一般	直接眼科	老視の原因	2・5
115B01	必修	弱い関連	有訴者の症状（目のかすみ）	2
115B08	必修	関連領域	壮年期の身体的変化（視機能の調節力）	3
115B13	必修	弱い関連	感覚性言語中枢（視覚野の選択肢）	4
115B46	一般	関連領域	有機リン中毒（縮瞳）	4
115B51	一般	直接眼科	眼底光凝固療法	4
115B78	一般	弱い関連	上大静脈症候群（眼瞼下垂の選択肢）	4
115B80	一般	弱い関連	急性腎不全の症状（視力低下の選択肢）	2
115B99	状況設定	関連領域	Basedow病（眼球突出）	4
115B100	状況設定	関連領域	慢性硬膜下血腫術後（視野障害・半側空間無視）	2
115B111	状況設定	弱い関連	光線療法（アイマスク）	4

115A03　レム睡眠（眼球運動）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：睡眠と眼球運動／出典：午前問題PDF 7ページ

レム睡眠の特徴はどれか。

1　骨格筋が緊張する。
2　急速な眼球運動を伴う。
3　体熱の放散が増加する。
4　大脳皮質の活動が低下する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	レム睡眠では骨格筋は弛緩（筋緊張消失）する。
2	正答	レム（REM）は急速眼球運動の略で、閉眼下で眼球が素早く動く。夢をみることが多い。
3	誤答	体温調節は低下し体熱放散は減る。
4	誤答	大脳皮質は覚醒時に近く活動する。活動が低下するのはノンレム睡眠。

公式正答：2　急速な眼球運動を伴う。

ポイント：眼球運動は睡眠段階の判定に使う。

115A20　接触感染予防策（ゴーグル）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：個人防護具と眼の防護／出典：午前問題PDF 12ページ

接触感染予防策として使用するのはどれか。

1　陰圧室
2　ガウン
3　ゴーグル
4　N 95マスク

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	陰圧室は空気感染（結核・麻疹・水痘）の対策。
2	正答	接触感染予防策では患者や環境に触れる際に手袋とガウンを着用する。
3	誤答	ゴーグル・フェイスシールドは眼の粘膜を飛沫・血液から守る装備で、接触感染予防策に特有ではない。
4	誤答	N95マスクは空気感染予防策。

公式正答：2　ガウン

ポイント：眼の防護具（ゴーグル、フェイスシールド）は「眼の結膜からの曝露」を防ぐためで、吸引・採血・創処置など飛散が予想される場面で使う。

115A25　対光反射に関与する神経

区分：必修／分類：直接眼科／主題：脳神経と眼（対光反射・眼球運動）／出典：午前問題PDF 14ページ

対光反射に関与するのはどれか。

1　動眼神経
2　滑車神経
3　三叉神経
4　外転神経
5　顔面神経

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	対光反射は、網膜→視神経（求心路）→中脳→動眼神経の副交感線維（遠心路）→瞳孔括約筋の経路で起こり、縮瞳する。
2	誤答	滑車神経は上斜筋を支配し、眼球を下内方へ動かす運動神経で、瞳孔の反射には関与しない。
3	誤答	三叉神経は顔面・角膜の知覚と咀嚼筋を担う。角膜反射の求心路ではあるが、対光反射には関与しない。
4	誤答	外転神経は外側直筋を支配し眼球を外転させる。瞳孔は動かさない。
5	誤答	顔面神経は表情筋（閉眼を含む）と涙腺・唾液腺の分泌を担う。対光反射には関与しない。

公式正答：1　動眼神経

ポイント：対光反射は「視神経で入り、動眼神経で出る」と覚える。片眼に光を当てると両眼が縮瞳する（直接・間接対光反射）。

整理：眼球運動の神経（動眼・滑車・外転）と、瞳孔の反射（動眼神経の副交感成分）を分けて整理する。

臨床上の補足：動眼神経麻痺では散瞳・眼瞼下垂・外下方への眼位ずれがそろう。脳ヘルニアでは同側の散瞳と対光反射消失が早期徴候になる。

115A47　職業と健康障害（緑内障・眼疲労）

区分：一般／分類：関連領域／主題：職業性疾病と眼／出典：午前問題PDF 21ページ

職業に伴う作業や環境と健康障害の組合せで正しいのはどれか。

1　紫外線の曝露 ― 緑内障
2　情報機器作業 ― 眼疲労
3　工具や機械の振動 ― 手指の熱感
4　重量物の取り扱い ― 骨粗鬆症

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	紫外線の曝露で起こる眼の障害は白内障、翼状片、電気性眼炎（雪眼炎）などで、緑内障ではない。
2	正答	長時間の画面注視は眼精疲労・ドライアイ・視力低下を起こす。情報機器作業ガイドラインでは連続作業1時間以内、10～15分の休止が目安。
3	誤答	工具の振動では手指の蒼白・冷感・しびれ（振動障害、白ろう病）が起こる。熱感ではない。
4	誤答	重量物の取り扱いで起こるのは腰痛などの筋骨格系障害。骨粗鬆症は職業性疾病ではない。

公式正答：2　情報機器作業 ― 眼疲労

ポイント：眼に関わる職業性疾病は、VDT作業（眼疲労）、紫外線・溶接光（白内障・電気性眼炎）、粉じん・化学物質（角結膜障害）を整理する。

整理：紫外線と緑内障を結びつけないこと。

115A88　老視の原因

区分：一般／分類：直接眼科／主題：水晶体・加齢（老視）／出典：午前問題PDF 34ページ

老視の原因はどれか。2つ選べ。

1　房水の循環障害
2　毛様体筋の萎縮
3　虹彩の弾力性の低下
4　網膜神経細胞の減少
5　水晶体の弾力性の低下

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	房水の循環障害は眼圧上昇をきたし、緑内障の原因になる。調節力の低下とは別の病態。
2	正答	毛様体筋が収縮すると毛様小帯が緩み水晶体が厚くなって近くにピントが合う。加齢で毛様体筋の働きが衰えると調節力が低下する。
3	誤答	虹彩は瞳孔の大きさ（光量）を調節する。弾力性の変化は老視の原因ではない。
4	誤答	網膜神経細胞の減少は視力・視野の障害に関わるが、ピント調節の低下である老視の原因ではない。
5	正答	加齢で水晶体が硬くなり弾力性が低下すると、厚くなれず近くにピントが合わなくなる。老視の主因。

公式正答：2　毛様体筋の萎縮、5　水晶体の弾力性の低下

ポイント：老視は40歳代から自覚される生理的変化で、近くが見にくくなる。白内障（水晶体の混濁）とは別の変化。

整理：「水晶体が濁る＝白内障」「水晶体が硬くなる＝老視」と区別する。

臨床上の補足：老視は凸レンズ（老眼鏡）で矯正する。近視の人は近くが見えやすいため自覚が遅れることがある。

115B01　有訴者の症状（目のかすみ）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：統計にみる眼症状／出典：午後問題PDF 7ページ

令和4年（2022年）の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状で最も多いのはどれか。

1　頻　尿
2　腰　痛
3　肩こり
4　目のかすみ

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	頻尿は高齢男性で多いが最多ではない。
2	正答	男性の有訴者の症状は腰痛が最多。
3	誤答	肩こりは女性で最多、男性では2位。
4	誤答	目のかすみは有訴者率の上位症状の一つだが最多ではない。

公式正答：2　腰　痛

ポイント：目のかすみは加齢（白内障・老視）やドライアイで増える訴えで、調査では男女とも上位に入る。

115B08　壮年期の身体的変化（視機能の調節力）

区分：必修／分類：関連領域／主題：水晶体・加齢（老視）／出典：午後問題PDF 8ページ

壮年期の身体的変化はどれか。

1　残気量の減少
2　柔軟性の向上
3　基礎代謝の低下
4　視機能の調節力の向上3

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	加齢で残気量は増加する。
2	誤答	柔軟性は低下する。
3	正答	基礎代謝は加齢とともに低下する。
4	誤答	水晶体の弾力性低下により調節力は低下し、老視が始まる。向上ではない。

公式正答：3　基礎代謝の低下

ポイント：40歳代以降の老視は壮年期の代表的な視機能変化。

115B13　感覚性言語中枢（視覚野の選択肢）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：大脳の機能局在と視覚／出典：午後問題PDF 10ページ

感覚性言語中枢はどれか。

1　視覚野
2　体性感覚野
3　Broca〈ブローカ〉野
4　Wernicke〈ウェルニッケ〉野

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	視覚野は後頭葉にあり、視覚情報を処理する。障害で同名半盲や皮質盲が起こる。
2	誤答	体性感覚野は頭頂葉。
3	誤答	Broca野は運動性言語中枢で前頭葉。
4	正答	Wernicke野は側頭葉の感覚性言語中枢で、障害では流暢だが理解できない失語になる。

公式正答：4　Wernicke〈ウェルニッケ〉野

ポイント：視覚路は網膜→視神経→視交叉→視索→外側膝状体→視放線→後頭葉視覚野。

115B46　有機リン中毒（縮瞳）

区分：一般／分類：関連領域／主題：中毒と瞳孔／出典：午後問題PDF 19ページ

A さん（58歳、男性）は農作業中に有機リン系殺虫剤を散布していたところ、急な嘔気と頭痛、呼吸困難が出現したため救急搬送された。搬入時、呼吸は促迫で流涎があり、縮瞳が認められた。A さんに直ちに投与される薬剤はどれか。

1　ビタミンK 製剤
2　オキシコドン塩酸塩
3　バンコマイシン塩酸塩
4　アトロピン硫酸塩水和物

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	ビタミンK製剤はワルファリン過量や新生児出血症に用いる。
2	誤答	オキシコドンは麻薬性鎮痛薬で、呼吸抑制を悪化させる。
3	誤答	バンコマイシンは抗菌薬で中毒治療に無関係。
4	正答	アトロピンはムスカリン受容体を遮断し、縮瞳・気道分泌・徐脈などを改善する。重症ではプラリドキシム（PAM）も併用する。

公式正答：4　アトロピン硫酸塩水和物

ポイント：縮瞳は有機リン中毒、麻薬中毒、橋出血の鑑別点。散瞳は抗コリン薬中毒や交感神経刺激薬で起こる。

整理：「縮瞳＝副交感優位」「散瞳＝交感優位」を薬物の作用と結びつける。

臨床上の補足：アトロピン投与後は散瞳・口渇・頻脈が出るが、気道分泌の減少を効果の指標にする。

115B51　眼底光凝固療法

区分：一般／分類：直接眼科／主題：眼底光凝固（網膜症治療）／出典：午後問題PDF 20ページ

成人の眼底光凝固療法において正しいのはどれか。

1　縮瞳させる。
2　静脈麻酔を行う。
3　眼球表面を消毒する。
4　レーザー用のコンタクトレンズを装着する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	眼底を広く観察・照射するため散瞳薬で散瞳させる。縮瞳させると眼底が見えない。
2	誤答	点眼麻酔（表面麻酔）で行う外来治療であり、静脈麻酔は通常不要。
3	誤答	手術のような眼球表面の消毒は行わない。点眼麻酔後にレンズを装着する。
4	正答	レーザーを網膜に正確に当てるため、角膜に専用のコンタクトレンズを装着して行う。

公式正答：4　レーザー用のコンタクトレンズを装着する。

ポイント：糖尿病網膜症や網膜裂孔などに対する治療。治療後は散瞳が数時間続くため、まぶしさや見えにくさがあり自動車運転は避ける。

整理：散瞳薬を使う検査・治療では「暗い部屋」「運転不可」「閉塞隅角緑内障の確認」がセットで問われる。

臨床上の補足：光凝固は進行を抑える治療で、視力を元に戻す治療ではないことを患者に説明する。

115B78　上大静脈症候群（眼瞼下垂の選択肢）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：全身疾患と眼（上大静脈症候群）／出典：午後問題PDF 30ページ

上大静脈症候群の症状はどれか。

1　喀　血
2　上腕痛
3　眼瞼下垂
4　顔面浮腫
5　胸水貯留25

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	喀血は上大静脈の閉塞では起こらない。
2	誤答	上腕痛はPancoast腫瘍などの腕神経叢浸潤で起こる。
3	誤答	眼瞼下垂は頸部交感神経障害（Horner症候群）や動眼神経麻痺で起こる。
4	正答	上大静脈の閉塞で頭頸部・上肢の静脈還流が障害され、顔面浮腫、眼瞼浮腫、頸静脈怒張が生じる。
5	誤答	胸水貯留は主症状ではない。

公式正答：4　顔面浮腫

ポイント：肺癌の局所症状として、上大静脈症候群（顔面浮腫）、Horner症候群（縮瞳・眼瞼下垂）、反回神経麻痺（嗄声）を区別する。

115B80　急性腎不全の症状（視力低下の選択肢）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：全身疾患と眼（腎不全）／出典：午後問題PDF 31ページ

急性腎不全の症状について正しいのはどれか。

1　関節痛
2　頻呼吸
3　食欲増進
4　視力低下
5　足のムズムズ

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	関節痛は腎不全の症状ではない。
2	正答	代謝性アシドーシスを呼吸性に代償するため呼吸数が増える（Kussmaul呼吸）。
3	誤答	食欲は低下する。
4	誤答	視力低下は糖尿病網膜症や高血圧性網膜症、慢性腎不全に伴う合併症として起こり得るが、急性腎不全の症状としては問われない。
5	誤答	足のムズムズ（レストレスレッグス症候群）は慢性腎不全・透析患者に多い。

公式正答：2　頻呼吸

ポイント：眼底は全身の血管を直接見られる場所で、高血圧・糖尿病・腎疾患の評価に使われる。

115B99　Basedow病（眼球突出）

区分：状況設定／分類：関連領域／主題：全身疾患と眼（甲状腺）／出典：午後問題PDF 41ページ

> 【状況設定文】A さん（21歳、女性、大学生）は半年ほど前から疲れやすさを自覚していた。その後、安静時にも息切れと動悸が出現するようになり、1か月前から所属するテニスサークルを休んでいる。数日前からは手が震えるようになり、学業にも支障が出てきた。頻繁に汗が出ると自覚しており、母親から「首が腫れている」と指摘され受診した。受診時は、身長160 cm、体重44 kg で半年前から6 kg 減少している。体温37.5 ℃、呼吸数22/分、脈拍132/分、血圧152/70 mmHg であった。

2週後の外来受診でA さんは「Basedow〈バセドウ〉病を知るほど怖くなってきた。眼が出ることもあるって。最近、足がつることが多くてテニスもできていない。就職が決まったけど働くことができるのかしら。将来、結婚したり妊娠したりできるのかも心配」と思いを訴えた。看護師の返答で適切なのはどれか。

1　「自宅療養が必要です」
2　「眼が出ることはありません」
3　「妊娠、出産は避けてください」
4　「症状が落ちつけば運動できます」

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	外来で内服治療を続けながら通学・就労できる。自宅療養は必須ではない。
2	誤答	Basedow病では眼球突出、眼瞼後退、複視などの甲状腺眼症が一定の割合で起こる。「ない」と断言するのは誤り。
3	誤答	甲状腺機能をコントロールすれば妊娠・出産は可能。妊娠中も内服薬を調整して治療を続ける。
4	正答	頻脈や動悸が落ち着けば運動は可能。足がつる症状は低カリウム性周期性四肢麻痺や筋力低下と関連し、治療で改善が期待できる。

公式正答：4　「症状が落ちつけば運動できます」

ポイント：甲状腺眼症は自己免疫による眼窩組織の炎症で、眼球突出・眼瞼腫脹・複視・角膜障害を起こす。喫煙は悪化因子。

整理：眼球突出は甲状腺機能の値と必ずしも並行しない。禁煙指導が重要。

臨床上の補足：重度の眼症では視神経圧迫で視力低下が起こるため眼科と連携する。

115B100　慢性硬膜下血腫術後（視野障害・半側空間無視）

区分：状況設定／分類：関連領域／主題：高次脳機能と視野／出典：午後問題PDF 42ページ

> 【状況設定文】A さん（68歳、女性、事務員）は夫（74歳、事務所長）と息子（39歳、会社員）と3人で暮らしている。現病歴：2か月前に自宅の廊下で転倒し、壁に右前額部をぶつけたが、そのまま様子をみていた。3週前から軽い頭痛があり、左上下肢の脱力感と言葉が出にくいなどの症状が出現した。かかりつけの病院を受診し、慢性硬膜下血腫と診断され、入院して穿頭ドレナージ術を受けた。既往歴：48歳から左変形性膝関節症で鎮痛薬を内服し、医師から体重コントロールを指導されていた。58歳から高血圧症と脂質異常症のため内服治療中であった。生活歴：入院前の日常生活動作〈ADL〉は自立しており、左膝関節痛のため室内は壁や家具に手をついて移動し、外出時はT 字杖を使用していた。家事をしながら夫の事務所を手伝っていた。身体所見：身長154 cm、体重72 kg。

手術後5日、A さんは左上肢に軽度の麻痺はあるが、病棟内を歩行器でゆっくりと歩けるようになった。A さんは、歩き始めると徐々に右側に寄っていく。また、左側の壁に歩行器をぶつけそうになったり、A さんの左側に看護師がいても気が付かず、そのまま通り過ぎようとしたりする。このときの A さんの状況で考えられるのはどれか。

1　左変形性膝関節症の悪化
2　半側空間無視
3　聴覚障害
4　視野障害37

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	左膝関節症の悪化では左側への注意が向かない現象は説明できない。
2	正答	右大脳半球（頭頂葉）の障害で左側の空間に注意が向かず、本人は気付かない。歩くと右に寄り、左側の人に気付かないのが典型。
3	誤答	聴覚障害では左側の看護師を見えていれば気付く。
4	誤答	左同名半盲でも左側が見えないが、患者は欠損に気付き顔を左に向けて補おうとする。気付かず通り過ぎるのは無視の特徴。

公式正答：2　半側空間無視

ポイント：視野障害（半盲）と半側空間無視の違いは「欠損を自覚して代償しようとするか」。看護では左側からの声かけと左側への注意を促す訓練を行う。

整理：視野検査は対座法、無視は線分二等分試験や模写で評価する。

115B111　光線療法（アイマスク）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：光線療法と眼の保護／出典：午後問題PDF 49ページ

> 【状況設定文】A さん（37歳、初産婦）は妊娠40週5日で妊娠経過は順調である。午前6時から15分おきの子宮収縮が始まり、午前9時から5～7分周期の陣痛がある。午前10時に入院し、入院時のバイタルサインは、体温36.9 ℃、脈拍80/分、血圧134/86 mmHg。子宮口3 cm 開大、未破水であった。

A さんの児は日齢4。児のバイタルサインに異常はない。経皮ビリルビン検査で生理的範囲を超え、医師の診察の結果、高ビリルビン血症と診断された。保育器に収容してスタンド型光線療法器で治療を開始することになった。A さんへの説明で適切なのはどれか。

1　「母乳を中止します」
2　「母児同室は継続できます」
3　「薄い衣服を着て治療します」
4　「アイマスクをして治療します」

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	母乳は中止しない。
2	誤答	保育器で光線療法を行うため同室は中断されるが、授乳時は中断できる。
3	誤答	皮膚の露出面積を広くするため衣服は脱がせる。
4	正答	強い光から網膜を守るためアイマスク（眼帯）で眼を覆う。授乳などで中断するときは外して眼の状態を確認する。

公式正答：4　「アイマスクをして治療します」

ポイント：光線療法中はアイマスクのずれによる光曝露や、締め付けによる眼周囲の圧迫がないか観察する。